

Appel d'offres AO-CLB-2026-01 — Cahier des charges fonctionnel et technique MédiRDV

Sep 28, 2026 · @Elias

Clinique Les Baobabs lance une consultation pour la conception, le développement et la mise en service de *MédiRDV*, une plateforme de gestion et d'analyse des rendez-vous médicaux. Le présent document constitue le cahier des charges fonctionnel et technique (CCFT) opposable aux soumissionnaires.

Fiche d'identification

Rubrique	Information
Maître d'ouvrage	Clinique Les Baobabs SA, Dakar (Sénégal)
Référence de la consultation	AO-CLB-2026-01
Objet	Plateforme MédiRDV : prise de rendez-vous, planification et tableau de bord analytique
Type de procédure	Appel d'offres restreint, lot unique
Niveau de complexité	Intermédiaire (projet de fin de Licence 3, spécialité science des données)
Durée d'exécution	12 semaines à compter de la notification
Date de publication	5 octobre 2026
Date limite de dépôt des offres	30 octobre 2026 à 12 h 00 (heure de Dakar)
Interlocuteur	Direction des opérations, Clinique Les Baobabs
Confidentialité	Diffusion restreinte aux soumissionnaires invités

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modification
0.9	21 septembre 2026	Direction des opérations	Projet soumis à la direction générale
1.0	28 septembre 2026	Direction des opérations	Version validée pour publication

Document pédagogique : la Clinique Les Baobabs et toutes les données citées sont fictives.

1. Présentation du maître d'ouvrage

La Clinique Les Baobabs est un établissement de santé privé situé à Dakar, fondé en 2011. Elle assure environ 48 000 consultations par an dans 9 spécialités, avec 120 employés dont 30 médecins.

1.1 Offre de soins

Spécialité	Médecins	Consultations par an (estimation)
Médecine générale	6	12 500
Pédiatrie	4	7 800
Gynécologie-obstétrique	4	6 900
Cardiologie	3	4 200
Dermatologie	2	3 600
Ophtalmologie	3	4 100
ORL	2	3 000
Endocrinologie	3	3 400
Kinésithérapie	3	2 500

1.2 Organisation concernée par le projet

- **Direction générale** : sponsor du projet, arbitre les priorités et le budget.

- **Direction des opérations** : pilote le projet, rédige le présent cahier des charges et prononce la recette.
- **Service accueil** : 8 agents qui prennent les rendez-vous par téléphone et au guichet.
- **Corps médical** : 30 médecins qui consultent leur planning et déclarent leurs indisponibilités.
- **Service informatique** : 2 techniciens chargés de l'exploitation après la mise en service.

1.3 Système d'information actuel

La clinique dispose d'un logiciel de facturation autonome et d'une messagerie. Les rendez-vous sont notés dans des cahiers papier et des tableurs partagés par spécialité. Aucun outil ne permet aujourd'hui de consolider l'activité.

2. Contexte, problématique et enjeux

2.1 Constat

L'audit interne mené en juin 2026 a relevé les dysfonctionnements suivants :

- **Doubles réservations** : environ 3 % des créneaux sont attribués deux fois, faute de planning centralisé.
- **Absences non signalées** : 14 % des rendez-vous ne sont pas honorés, sans suivi ni relance.
- **Saturation mal répartie** : les lundis et samedis matin, l'attente au guichet dépasse 45 minutes, alors que des créneaux restent vides en milieu de semaine.
- **Aucun pilotage** : la direction ne dispose d'aucun indicateur fiable sur l'activité par spécialité, par médecin ou par période.

2.2 Problématique

Comment centraliser la prise de rendez-vous des 9 spécialités, fiabiliser les plannings et exploiter les données d'activité pour mieux répartir la demande et réduire les absences ?

2.3 Enjeux

Enjeu	Description
Qualité de service	Réduire l'attente et les erreurs de planification pour les patients
Efficacité opérationnelle	Libérer du temps pour les agents d'accueil et mieux remplir les agendas

Enjeu	Description
Pilotage	Donner à la direction des indicateurs fiables pour ajuster les effectifs
Conformité	Protéger les données personnelles conformément à la loi sénégalaise n° 2008-12
Évolutivité	Préparer de futurs modules : rappels SMS, téléconsultation, prévision avancée

3. Objet, objectifs et périmètre

3.1 Objet de la consultation

La consultation porte sur la réalisation clé en main de MédiRDV : conception, développement, tests, documentation, déploiement sur l'environnement de la clinique et transfert de compétences.

3.2 Objectifs mesurables

Code	Objectif	Indicateur	Cible à 6 mois
OBJ-1	Supprimer les doubles réservations	Nombre de conflits de créneau	0
OBJ-2	Réduire les rendez-vous non honorés	Taux d'absence	De 14 % à 11 % (−20 %)
OBJ-3	Mieux répartir la demande	Taux d'occupation des créneaux en milieu de semaine	De 58 % à 70 %
OBJ-4	Accélérer la prise de rendez-vous	Durée moyenne de saisie par un agent	Moins de 2 minutes
OBJ-5	Doter la direction d'indicateurs	Tableau de bord mis à jour	Quotidiennement, sans intervention manuelle

3.3 Périmètre inclus

- Gestion des patients, des médecins, des spécialités et des plannings.
- Prise, modification, annulation et suivi des rendez-vous.
- Tableau de bord statistique et module d'analyse de la demande.

- API documentée, authentification et gestion des rôles.
- Génération d'un jeu de données synthétique pour les tests et la démonstration.

3.4 Hors périmètre

- Dossier médical, diagnostics, prescriptions et résultats d'examens.
- Facturation et paiement en ligne.
- Application mobile native (une interface web adaptée au mobile suffit).
- Envoi réel de SMS : le module de rappel est simulé dans cette phase.

4. Acteurs et profils utilisateurs

L'application distingue cinq rôles. Chaque utilisateur a un seul rôle ; les droits sont cumulatifs uniquement pour l'administrateur.

Rôle	Nombre	Besoins principaux	Droits
Agent d'accueil	8	Trouver vite un créneau libre, enregistrer un patient, confirmer ou annuler	Créer, modifier et annuler des rendez-vous ; gérer les fiches patients
Médecin	30	Consulter son planning du jour et de la semaine, déclarer ses absences	Lecture de son planning ; saisie de ses indisponibilités ; marquage « honoré / absent »
Responsable des opérations	2	Suivre l'activité, repérer les périodes de saturation, ajuster les créneaux	Lecture de tous les plannings ; accès complet au tableau de bord ; export
Direction générale	3	Vision synthétique mensuelle	Lecture du tableau de bord synthétique
Administrateur	2	Paramétrer spécialités, médecins, horaires et comptes	Tous les droits, y compris la gestion des utilisateurs

Le patient n'accède pas directement à l'application dans cette phase. Un portail patient pourra faire l'objet d'une tranche ultérieure.

4.1 Scénario type

Un patient appelle pour une consultation en pédiatrie. L'agent recherche le premier créneau libre de la semaine, choisit le médecin, vérifie la fiche patient (ou la crée) et confirme. Le rendez-vous apparaît aussitôt dans le planning du médecin. Le jour J, le médecin marque le rendez-vous comme honoré ; sinon il passe automatiquement en « absent » une heure après le créneau.

5. Exigences fonctionnelles

Chaque exigence porte un identifiant unique, repris dans la matrice de conformité (annexe B). Priorités : **P1** obligatoire, **P2** attendu, **P3** optionnel valorisé.

5.1 Module M1 — Référentiels

ID	Exigence	Priorité
EF-01	Gérer les spécialités : nom, durée standard d'une consultation (15, 20 ou 30 minutes), couleur d'affichage	P1
EF-02	Gérer les médecins : nom, spécialité(s), jours et plages de consultation	P1
EF-03	Gérer les fiches patients : identifiant, nom, prénom, date de naissance, téléphone, sexe	P1
EF-04	Détecter les doublons de patients (même nom, prénom et date de naissance) avant création	P2
EF-05	Gérer les jours fériés et fermetures exceptionnelles	P2

5.2 Module M2 — Plannings et rendez-vous

ID	Exigence	Priorité
EF-10	Générer automatiquement les créneaux à partir des plages horaires et de la durée de la spécialité	P1
EF-11	Rechercher le premier créneau libre par spécialité, médecin et période	P1
EF-12	Créer, modifier, déplacer et annuler un rendez-vous, avec motif d'annulation	P1

ID	Exigence	Priorité
EF-13	Bloquer toute double réservation d'un même médecin ou d'un même patient sur un créneau	P1
EF-14	Déclarer une indisponibilité de médecin et lister les rendez-vous impactés à reprogrammer	P1
EF-15	Afficher le planning en vues jour, semaine et liste, filtrable par spécialité et médecin	P1
EF-16	Gérer le statut d'un rendez-vous : planifié, confirmé, honoré, absent, annulé	P1
EF-17	Passer automatiquement en « absent » un rendez-vous non marqué une heure après son début	P2
EF-18	Tenir une liste d'attente par spécialité et proposer les créneaux libérés	P3

5.3 Module M3 — Tableau de bord et analyse

ID	Exigence	Priorité
EF-20	Indicateurs clés du jour : rendez-vous prévus, honorés, absents, taux d'occupation	P1
EF-21	Répartition des rendez-vous par spécialité, jour de la semaine et heure (carte de chaleur)	P1
EF-22	Évolution mensuelle du volume et du taux d'absence par spécialité	P1
EF-23	Filtres par période, spécialité et médecin sur tous les graphiques	P1
EF-24	Prévision du volume hebdomadaire de demandes par spécialité sur 4 semaines	P2
EF-25	Score de risque d'absence par rendez-vous et liste des rendez-vous à relancer	P2
EF-26	Export CSV et PDF des indicateurs	P2

5.4 Module M4 — Administration et sécurité

ID	Exigence	Priorité
EF-30	Authentification par identifiant et mot de passe	P1
EF-31	Gestion des comptes et des rôles (section 4)	P1
EF-32	Journal des actions : qui a créé, modifié ou annulé quel rendez-vous, et quand	P1
EF-33	Simulation des rappels : liste quotidienne des patients à prévenir la veille, avec message type	P3

6. Règles de gestion

Les règles suivantes s'imposent à l'application et doivent être vérifiées côté serveur, pas seulement dans l'interface.

ID	Règle
RG-01	Un créneau d'un médecin ne peut porter qu'un seul rendez-vous actif (statut planifié, confirmé ou honoré).
RG-02	Un patient ne peut pas avoir deux rendez-vous actifs qui se chevauchent, toutes spécialités confondues.
RG-03	Un rendez-vous ne peut être pris que dans les plages ouvertes du médecin, hors jours fériés et indisponibilités.
RG-04	Un rendez-vous ne peut pas être créé dans le passé ni plus de 90 jours à l'avance.
RG-05	Une annulation exige un motif choisi dans une liste (patient, médecin, clinique, autre).
RG-06	Un rendez-vous annulé libère immédiatement le créneau.
RG-07	Seul le médecin concerné, un responsable des opérations ou un administrateur peut marquer un rendez-vous « honoré » ou « absent ».

ID	Règle
RG-08	Un patient totalisant 3 absences sur les 6 derniers mois est signalé à l'agent lors d'une nouvelle prise de rendez-vous.
RG-09	Le taux d'absence se calcule ainsi : rendez-vous « absent » ÷ (rendez-vous « honoré » + « absent »), sur la période choisie. Les annulations sont exclues.
RG-10	Le taux d'occupation se calcule ainsi : créneaux portant un rendez-vous honoré ou absent ÷ créneaux ouverts, sur la période choisie.
RG-11	Toute modification d'un rendez-vous est historisée ; aucune suppression physique n'est autorisée.

6.1 Cycle de vie d'un rendez-vous

1. **Planifié** : créé par un agent.
2. **Confirmé** : le patient a confirmé sa venue (appel de rappel).
3. **Honoré** ou **Absent** : état final fixé le jour du rendez-vous (RG-07, EF-17).
4. **Annulé** : possible à partir des états planifié ou confirmé uniquement (RG-05).

7. Données

7.1 Modèle de données minimal

Le titulaire peut enrichir ce modèle, mais doit conserver ces entités et ces relations.

Entité	Attributs principaux	Relations
Specialite	id, nom, duree_minutes, couleur	1 spécialité → n médecins
Medecin	id, nom, prenom, actif	n médecins ↔ n spécialités ; 1 médecin → n plages
PlageHoraire	id, medecin_id, jour_semaine, heure_debut, heure_fin	1 plage → n créneaux
Indisponibilite	id, medecin_id, debut, fin, motif	liée à 1 médecin
Patient	id, nom, prenom, date_naissance, sexe, telephone	1 patient → n rendez-vous

Entité	Attributs principaux	Relations
RendezVous	id, patient_id, medecin_id, specialite_id, debut, fin, statut, motif_annulation, cree_par, cree_le	lié à 1 patient, 1 médecin, 1 spécialité
HistoriqueRdv	id, rdv_id, champ, ancienne_valeur, nouvelle_valeur, utilisateur_id, horodatage	1 rendez-vous → n entrées
Utilisateur	id, identifiant, mot_de_passe_hache, role, actif	1 utilisateur → n actions

7.2 Jeu de données synthétique

Aucune donnée réelle de patient ne sera transmise au titulaire. Celui-ci fournit un générateur reproductible (graine aléatoire fixée) qui produit au minimum :

- 12 mois d'historique et 3 mois de rendez-vous futurs ;
- 30 médecins, 9 spécialités, 1 000 patients fictifs ;
- au moins 5 000 rendez-vous passés, avec des effets réalistes : pics le lundi et le samedi matin, saisonnalité (hausse en saison des pluies), taux d'absence variable selon le délai de prise de rendez-vous, l'âge et la spécialité ;
- des anomalies volontaires documentées (doublons de patients, téléphones mal formés) pour tester les contrôles.

7.3 Qualité des données

Le titulaire met en place des contrôles à la saisie (formats de téléphone sénégalais, dates cohérentes, champs obligatoires) et un rapport de qualité listant les valeurs manquantes, doublons et incohérences détectés dans la base.

8. Analyse de données et tableau de bord

Le volet science des données, de niveau intermédiaire, comprend trois livrables : les indicateurs, la prévision de la demande et le score de risque d'absence.

8.1 Indicateurs du tableau de bord

Indicateur	Définition	Granularité	Fréquence
Volume de rendez-vous	Nombre de rendez-vous par statut	Jour, semaine, mois ; spécialité ; médecin	Temps réel

Indicateur	Définition	Granularité	Fréquence
Taux d'absence	Selon RG-09	Semaine, mois ; spécialité	Quotidienne
Taux d'occupation	Selon RG-10	Jour, semaine ; spécialité ; médecin	Quotidienne
Délai d'attente	Jours entre la prise et la date du rendez-vous (médiane)	Spécialité	Quotidienne
Carte de chaleur de la demande	Rendez-vous par jour de la semaine × heure	Spécialité	Hebdomadaire
Taux d'annulation	Annulés ÷ total créés, par motif	Mois ; spécialité	Quotidienne

8.2 Prévision de la demande (EF-24)

- Prévoir le nombre hebdomadaire de rendez-vous par spécialité sur un horizon de 4 semaines.
- Comparer au moins deux méthodes : une référence naïve (même semaine de l'année précédente ou moyenne mobile) et un modèle statistique ou d'apprentissage (Holt-Winters, SARIMA ou régression avec variables calendaires).
- Évaluer sur les 8 dernières semaines tenues à l'écart, avec MAE et MAPE.
- Afficher la prévision avec un intervalle d'incertitude.

8.3 Score de risque d'absence (EF-25)

- Modèle de classification (régression logistique et forêt aléatoire au minimum) estimant la probabilité qu'un rendez-vous ne soit pas honoré.
- Variables autorisées : délai entre prise et rendez-vous, jour et heure, spécialité, âge du patient, historique d'absences, confirmation ou non.
- Métriques : AUC, précision et rappel au seuil retenu, matrice de confusion. Le seuil est justifié par un raisonnement coût / bénéfice (coût d'un appel de relance contre coût d'un créneau perdu).
- Le score est une aide à la relance : il ne doit jamais bloquer une prise de rendez-vous ni être visible par le patient.

8.4 Documentation analytique

Un notebook ou rapport reproductible présente l'exploration des données, les choix de variables, les résultats chiffrés et les limites (données synthétiques, biais possibles, dérive dans le temps).

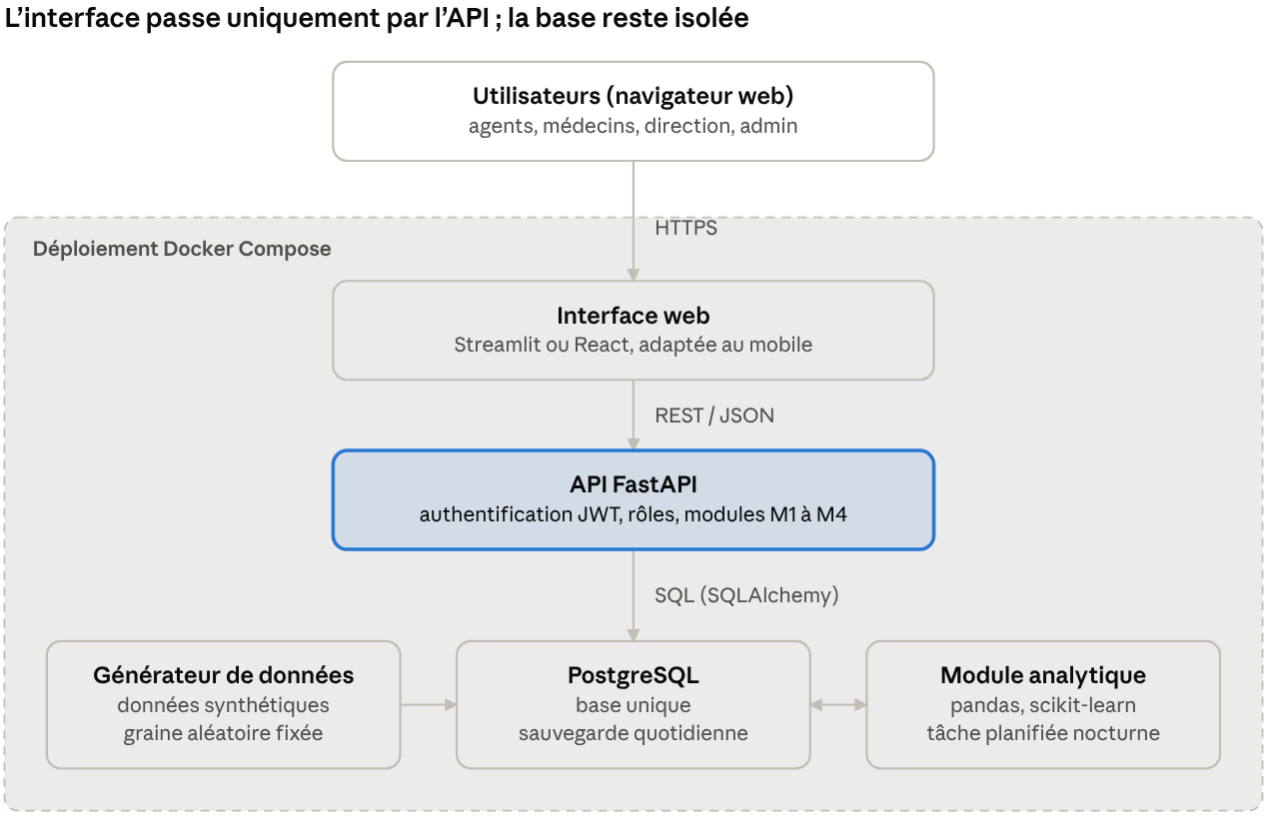
9. Exigences non fonctionnelles

ID	Catégorie	Exigence	Priorité
ENF-01	Performance	Réponse de l'API en moins de 500 ms pour 95 % des requêtes, avec 20 utilisateurs simultanés	P1
ENF-02	Performance	Chargement du tableau de bord en moins de 3 secondes sur 12 mois de données	P1
ENF-03	Disponibilité	Service accessible de 7 h à 20 h, 6 jours sur 7 ; redémarrage automatique des conteneurs	P2
ENF-04	Sécurité	Mots de passe hachés (bcrypt ou Argon2) ; politique de 10 caractères minimum	P1
ENF-05	Sécurité	Contrôle d'accès par rôle vérifié sur chaque point d'API	P1
ENF-06	Sécurité	Protection contre les injections SQL et les failles XSS ; en-têtes de sécurité HTTP	P1
ENF-07	Sécurité	Communication chiffrée (HTTPS) en production	P2
ENF-08	Conformité	Respect de la loi n° 2008-12 sur la protection des données personnelles : minimisation, finalité, durée de conservation documentée	P1
ENF-09	Conformité	Aucune donnée médicale (diagnostic, traitement) stockée dans MédiRDV	P1
ENF-10	Sauvegarde	Sauvegarde quotidienne de la base, procédure de restauration testée	P2
ENF-11	Ergonomie	Interface en français, utilisable sur tablette et téléphone (responsive)	P1
ENF-12	Ergonomie	Prise d'un rendez-vous standard en 5 clics au plus	P2
ENF-13	Accessibilité	Contrastes suffisants et navigation au clavier (niveau AA visé)	P3

ID	Catégorie	Exigence	Priorité
ENF-14	Maintenabilité	Code commenté, respect des conventions (PEP 8), couverture de tests d'au moins 70 % sur la logique métier	P1
ENF-15	Portabilité	Déploiement complet par une seule commande Docker Compose	P1
ENF-16	Traçabilité	Journaux applicatifs horodatés, sans donnée personnelle en clair	P2

10. Architecture et environnement techniques

10.1 Architecture cible



Architecture cible de MédiRDV · 5 composants

L'interface ne dialogue qu'avec l'API ; seule l'API et le module analytique accèdent à la base. Le module analytique calcule chaque nuit les indicateurs, la prévision et les scores, puis les enregistre dans des tables dédiées lues par l'API.

10.2 Pile technique imposée

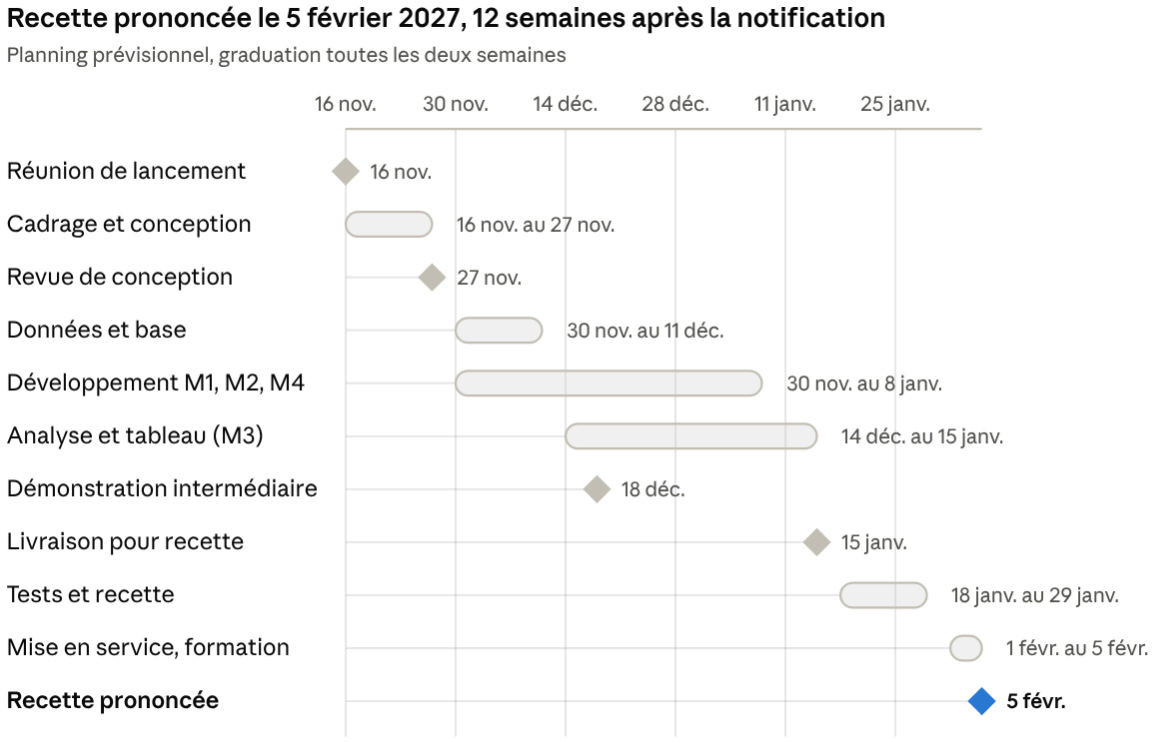
Couche	Technologie	Statut
Langage	Python 3.11 ou supérieur	Imposé
API	FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, Alembic pour les migrations	Imposé
Base de données	PostgreSQL 15 ou supérieur	Imposé
Interface	Streamlit ou React (au choix du soumissionnaire, à justifier)	Au choix
Analyse	pandas, scikit-learn, statsmodels, Plotly	Imposé
Tests	pytest, couverture mesurée	Imposé
Conteneurisation	Docker, Docker Compose	Imposé
Versionnement	Git, dépôt partagé avec la clinique	Imposé
Documentation API	OpenAPI / Swagger généré automatiquement	Imposé

10.3 Environnements

Trois environnements sont attendus : développement (poste du titulaire), recette (serveur de test de la clinique) et production (serveur Linux de la clinique, 4 vCPU, 8 Go de RAM). Toute configuration sensible passe par des variables d'environnement, jamais dans le code.

11. Planning et jalons

La durée d'exécution est de 12 semaines à compter de la notification, prévue le 16 novembre 2026. Le soumissionnaire peut proposer un autre découpage, à condition de respecter la date de mise en service.



Planning prévisionnel · 6 phases, 5 jalons

Chaque jalon donne lieu à une réunion avec la direction des opérations et à un compte rendu écrit. La revue de conception valide les maquettes, le modèle de données et le plan de tests avant tout développement.

11.1 Gouvernance

- **Comité de suivi** hebdomadaire (30 minutes) : chef de projet du titulaire et direction des opérations.
- **Comité de pilotage** à chaque jalon : direction générale, direction des opérations, titulaire.
- **Outil de suivi** : tableau des tâches partagé (GitHub Projects, GitLab ou équivalent), mis à jour chaque semaine.

12. Livrables, tests et recette

12.1 Livrables attendus

Code	Livrable	Jalon	Format
L1	Dossier de conception : maquettes, modèle de données, architecture, plan de tests	Revue de conception	PDF et fichiers sources
L2	Générateur de données synthétiques et rapport de qualité	Démonstration intermédiaire	Code Python et rapport
L3	Application complète (API, interface, module analytique)	Livraison pour recette	Dépôt Git, images Docker
L4	Notebook ou rapport d'analyse (prévision, score d'absence)	Livraison pour recette	Notebook exécutable et PDF
L5	Suite de tests automatisés et rapport de couverture	Livraison pour recette	pytest, rapport HTML
L6	README d'installation, documentation technique et documentation de l'API	Livraison pour recette	Markdown, Swagger
L7	Guide utilisateur par rôle	Mise en service	PDF illustré
L8	Support et session de formation (2 heures)	Mise en service	Présentation
L9	Procès-verbal de recette signé	Recette prononcée	PDF

12.2 Stratégie de tests

- **Tests unitaires** sur toutes les règles de gestion RG-01 à RG-11.
- **Tests d'intégration** de l'API : chaque point d'accès, chaque rôle, cas autorisés et refusés.
- **Tests de charge** simples (Locust ou équivalent) pour vérifier ENF-01 et ENF-02.
- **Tests de sécurité** de base : injection SQL, accès sans jeton, accès d'un rôle non autorisé.
- **Validation analytique** : les indicateurs du tableau de bord sont recalculés par requêtes SQL indépendantes et doivent correspondre exactement.

12.3 Procédure de recette

1. Le titulaire livre L3 à L6 et installe l'application sur l'environnement de recette à partir du seul README.
2. La clinique déroule un cahier de recette d'au moins 40 cas de test, couvrant toutes les exigences P1.
3. Les anomalies sont classées : **bloquante** (exigence P1 non remplie), **majeure** (P2 non remplie ou contournement lourd), **mineure** (gêne sans impact fonctionnel).
4. La recette est prononcée si aucune anomalie bloquante ni majeure ne subsiste. Les anomalies mineures sont corrigées pendant la garantie.
5. Le titulaire dispose de 5 jours ouvrés pour corriger les anomalies relevées lors de chaque cycle, dans la limite de deux cycles.

12.4 Garantie et transfert

Une garantie de 3 mois court à compter de la recette : correction gratuite des anomalies. Le code source, la documentation et les droits d'utilisation sont transférés à la clinique.

13. Modalités de la consultation

13.1 Calendrier de la consultation

Étape	Date
Publication de l'appel d'offres	5 octobre 2026
Date limite des questions écrites	16 octobre 2026
Réponses publiées à tous les soumissionnaires	21 octobre 2026
Date limite de dépôt des offres	30 octobre 2026, 12 h 00
Soutenances orales des candidats retenus	9 au 11 novembre 2026
Notification du titulaire	16 novembre 2026

13.2 Contenu de l'offre

L'offre, rédigée en français, comprend :

1. **Lettre de candidature** et présentation de l'équipe (rôles, compétences, CV courts).
2. **Mémoire technique** (15 pages maximum) : compréhension du besoin, architecture proposée, choix techniques justifiés, approche analytique, gestion des risques.

3. **Planning détaillé** et organisation du projet.
4. **Matrice de conformité** (annexe B) entièrement renseignée.
5. **Offre financière** détaillée par phase, en francs CFA (FCFA), hors taxes et toutes taxes comprises.
6. **Références** de projets similaires, le cas échéant.

13.3 Critères de sélection

Critère	Pondération
Valeur technique : architecture, qualité des choix, sécurité	35 %
Compréhension du besoin et couverture fonctionnelle (matrice de conformité)	20 %
Approche analytique : indicateurs, prévision, score d'absence	15 %
Méthodologie, planning et gestion des risques	10 %
Prix	15 %
Qualité de la soutenance orale	5 %

Une offre qui ne couvre pas toutes les exigences P1 est déclarée non conforme.

13.4 Dépôt et contact

Les offres sont déposées sous format électronique (PDF) auprès de la direction des opérations de la Clinique Les Baobabs, à l'adresse indiquée dans la lettre d'invitation. Les questions sont posées par écrit, avec la référence AO-CLB-2026-01 en objet. Les réponses sont communiquées à tous les soumissionnaires de manière anonyme.

13.5 Dispositions diverses

- Les offres restent valables 90 jours à compter de la date limite de dépôt.
- La clinique se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation.
- Les soumissionnaires s'engagent à la confidentialité sur toutes les informations reçues.

Annexe A — Glossaire

Terme	Définition
Maître d'ouvrage	Clinique Les Baobabs, commanditaire du projet
Titulaire	Soumissionnaire retenu à l'issue de la consultation
Créneau	Intervalle de temps réservable d'un médecin, dont la durée dépend de la spécialité
Taux d'absence	Part des rendez-vous non honorés parmi les rendez-vous arrivés à échéance (RG-09)
Taux d'occupation	Part des créneaux ouverts effectivement réservés (RG-10)
Données synthétiques	Données générées par programme, sans lien avec des personnes réelles
API	Interface de programmation permettant aux composants d'échanger des données
JWT	Jeton signé servant à authentifier un utilisateur auprès de l'API
Recette	Vérification formelle, par le maître d'ouvrage, de la conformité de la solution livrée
MAE / MAPE	Erreur absolue moyenne / erreur absolue moyenne en pourcentage d'une prévision
AUC	Aire sous la courbe ROC, mesure de la capacité d'un modèle à séparer deux classes

Annexe B — Matrice de conformité (à renseigner par le soumissionnaire)

Pour chaque exigence, indiquer : **C** (conforme), **CP** (conforme partiellement, préciser) ou **NC** (non conforme), et la page du mémoire technique qui y répond.

Exigence	Priorité	Réponse (C / CP / NC)	Commentaire et référence
EF-01 à EF-05 — Référentiels	P1 / P2		

Exigence	Priorité	Réponse (C / CP / NC)	Commentaire et référence
EF-10 à EF-18 — Plannings et rendez-vous	P1 à P3		
EF-20 à EF-26 — Tableau de bord et analyse	P1 / P2		
EF-30 à EF-33 — Administration et sécurité	P1 / P3		
RG-01 à RG-11 — Règles de gestion	P1		
ENF-01 à ENF-16 — Exigences non fonctionnelles	P1 à P3		
Section 10 — Pile technique imposée	P1		
Section 12 — Livrables L1 à L9	P1		

Fin du cahier des charges. Référence AO-CLB-2026-01, version 1.0.